



RESUMO DE AULA · JORNADA DA LEITURA

Processos emocionais e afeto

CAPÍTULO 9

Da geração da emoção à resposta: o ciclo afetivo, o modelo processual de regulação, e por que nenhuma estratégia é boa ou ruim em si — o que decide é o contexto, a história e a flexibilidade de uso.

PROFESSOR E PSICÓLOGO CLÍNICO

Júlio Gonçalves

MSc · CRP 12/17614

Aprenda muito mais na

Comunidade Lógica Psicológica

Uma comunidade para quem quer:

- Ψ **Aprofundar o raciocínio clínico** com conteúdos que unem ciência, processos e análise funcional.
- Ψ **Estruturar uma prática ética e coerente**, com pensamento crítico e evidências atualizadas.
- Ψ **Desenvolver o self clínico** por meio de supervisão, leituras guiadas e construção em rede.

Clique aqui e saiba mais



O ESSENCIAL

- Ψ **Emoções são amorais.** O que recebe julgamento social é o comportamento que vem depois — não a emoção em si.
- Ψ **Nenhuma estratégia é boa ou ruim isoladamente.** A adequação depende do contexto, da história da pessoa e das condições fisiológicas. O que adoece é o *uso rígido* de uma única estratégia.
- Ψ **A “situação” é o elo mais mal explorado** do modelo de geração emocional — e é onde começam situação → atenção → avaliação → resposta.
- Ψ **Regular não é regular sempre.** O objetivo inclui permitir a expressão quando ela é pertinente, monitorando intensidade e temporalidade.
- Ψ **Emoção positiva também se treina.** Muitos pacientes têm limitação severa para vivenciar prazer e reter memórias boas — e isso é alvo clínico, não bônus.

A emoção como mecanismo transdiagnóstico

A forma como a psicologia olhou para a emoção mudou três vezes. Primeiro ela foi tratada como **epifenômeno da cognição** — consequência do pensamento, sem estatuto próprio. Depois, como **sintoma a ser reduzido**. Na TBP, ela aparece como **mecanismo transdiagnóstico central**: um processo que atravessa quadros diferentes e que se avalia pela função, não pelo rótulo.

Esse deslocamento tem consequência prática imediata. Se a emoção é sintoma, o sucesso é ela ficar menor. Se é processo, o sucesso é ela ficar **funcional** — o que às vezes significa mais intensa, e não menos.

A cultura da razão — e as emoções como amorais

A aula abriu por uma crítica cultural: a herança da divisão cartesiana, que na cultura brasileira aparece como desconsideração ou repressão da emoção em favor da razão. As emoções são cruciais para a compreensão do mundo, e o trabalho clínico deve **acolher essas experiências** em vez de tratá-las como erro a corrigir.

EMOÇÕES NÃO TÊM MORAL

A classificação usada foi a de Dalgarrondo: **emoções são amorais**. O que recebe julgamento moral é o **comportamento subsequente**, e conforme o contexto social. Raiva não é ruim; o que se faz com ela pode ser. Essa distinção é o que permite validar a experiência sem endossar a conduta.

Daí decorre a discussão sobre **educação socioemocional** nas escolas, que ainda enfrenta resistência de parte dos educadores. Materiais acessíveis ajudam na alfabetização emocional dos pacientes — de cadernos de exercícios de inteligência emocional a filmes que dão nome e forma às emoções.

O que a clínica esquece: as emoções positivas

Um exercício simples abriu o tema: recordar um momento marcante e positivo da própria vida. Fácil de propor, difícil de fazer para boa parte dos pacientes.

O ponto clínico é que **pacientes costumam ter dificuldade em reter memórias positivas**, com o foco preso a traumas e situações negativas. Foi relatado o caso de um paciente de 21 anos que, tendo tido uma experiência boa com o pai, só conseguiu acessar aquela lembrança **no final da sessão** — depois de todo o resto.

A resposta a isso é intervenção, não conversa fiada: incentivar o **savoring**, o saborear deliberado dos momentos bons (Bryant & Veroff, 2007). E há um dado desconfortável que aparece com frequência: muitas pessoas têm **limitação severa para vivenciar prazer e recompensa** mesmo dispondo de recursos para isso. Não é falta de oportunidade — é falta de repertório.

SOBRE ROMPER PROTOCOLO

Houve discussão sobre quebrar a rigidez do enquadre em momentos específicos — compartilhar uma celebração, por exemplo. Feito com critério, fortalece o vínculo e ajuda o paciente a acolher experiências positivas; e serve também de contrapeso para o terapeuta, que ouve histórias difíceis todos os dias.

Para dar linguagem a isso, foi mencionado o uso de escalas de bem-estar subjetivo como recurso para o paciente **conhecer, nomear e equilibrar** as próprias emoções — um instrumento a serviço da autorregulação, não do escore.

O ciclo do processo afetivo

O processo afetivo é um mecanismo **dinâmico e cíclico**: geração, modulação, atenção e resposta comportamental. O desafio clínico é ajudar o paciente a desenvolver **capacidade reflexiva e**

regulatória — para que exista um intervalo entre sentir e agir.

O modelo de geração emocional encadeia quatro elos: **situação** (o gatilho, e o elo que raramente é bem explorado), **atenção** (o processamento cognitivo do estímulo), **avaliação** (o significado dado à experiência) e **resposta**. Cada elo admite uma estratégia de regulação diferente — quanto mais cedo no ciclo, mais “antecedente” é a estratégia.

O contexto não é cenário

Dois exemplos deixaram isso claro. Um adolescente cujo banho demorado era **forma de rebeldia contra o pai** — o comportamento não se explicava por desregulação, e sim pela relação. E um adolescente com reações intensas, gritos e rigidez cognitiva em escolas com gestão inadequada que, **ao mudar para uma escola com coordenação e professores que funcionavam bem, passou a apresentar comportamento socialmente esperado**.

O segundo caso é o mais instrutivo: mesma pessoa, mesmo repertório, contexto diferente, resultado diferente. Insatisfação profissional e conflito familiar operam do mesmo jeito em adultos — disparam processos afetivos intensos que depois se lê como “desregulação do paciente”.

Regulação emocional: o modelo processual de Gross

A definição de trabalho, seguindo Gross (1998, 2015): os processos **extrínsecos e intrínsecos** pelos quais a pessoa monitora, avalia e modifica suas reações emocionais para atingir objetivos pessoais. A regulação pode ser **intrapessoal ou interpessoal**, e serve a várias funções: aliviar sofrimento, mas também adaptar-se a contextos sociais e institucionais.

O OBJETIVO NÃO É REGULAR SEMPRE

Regular não significa manter a emoção baixa o tempo todo. O objetivo inclui **permitir a expressão quando ela é pertinente** — monitorando a **intensidade** e a **temporalidade**, em nome da adequação. Um paciente que nunca se irrita não está regulado; está suprimindo.

O modelo processual organiza as estratégias segundo *onde* elas agem no ciclo. As **antecedentes** — seleção da situação, modificação da situação, direcionamento da atenção e reavaliação cognitiva — operam *antes* da experiência emocional plena. As **focadas na resposta** agem depois que a emoção já se instalou.

As estratégias, uma a uma — e seus custos

O princípio que organiza esta seção: **não existem estratégias intrinsecamente boas ou ruins**. A adequação depende do contexto, da história da pessoa e das condições fisiológicas (Aldao, 2013; Bonanno & Burton, 2013). O que caracteriza saúde é a **flexibilidade** no uso; o que reforça a patologia é o uso rígido de uma estratégia só.

- Ψ **Seleção da situação** — reduz a exposição emocional. Útil, e com custo se for a única carta na mão.
- Ψ **Modificação da situação** — reduz a intensidade e aumenta o senso de controle. O alerta: modificar constantemente tem preço interpessoal. Pais que limitam demais a autonomia dos filhos por medo prejudicam a relação e o desenvolvimento do outro.
- Ψ **Direcionamento da atenção** — a distração ajuda pontualmente. Crônica, **impede o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento**: a pessoa nunca aprende que aguentaria.
- Ψ **Reavaliação cognitiva** — dar novo sentido ao que não se pode controlar. Poderosa, e com uma ressalva ética séria: usada sem critério, pode **perpetuar abusos ou passividade**. Nem tudo que dói pede resignificação; algumas coisas pedem mudança de situação.
- Ψ **Exposição emocional** — facilita a aprendizagem, e exige manejo cauteloso para não retraumatizar.
- Ψ **Supressão** — atua depois da resposta. Problemática a longo prazo porque **impede a elaboração** da emoção; pontualmente funcional quando expressar ali não é opção.
- Ψ **Regulação fisiológica** — respiração e relaxamento importam nos momentos de hiperativação. Contraproducentes quando usados como **fuga**.
- Ψ **Preocupação e ruminação** — dão sensação de controle e perpetuam o sofrimento, prendendo a pessoa ao problema.

Um caso ilustrou a avaliação de funcionalidade: um paciente de 32 anos com padrão de evitação experiencial que decide não ir a um evento — por economia e para não encontrar gatilhos. A decisão pode ser sensata ou pode ser mais uma esquiva. **A pergunta não é o que ele fez, e sim o que aquilo está fazendo por ele.**

Avaliar por falhas do sistema, não por rótulo

A proposta de avaliação dispensa a rotulação diagnóstica e busca identificar **onde o sistema emocional está falhando: hiperativação** (resposta desproporcional em intensidade ou duração), **hipoativação** (embotamento, dificuldade de acessar a experiência), **evitação experiencial** (Hayes et al., 1996) e **rigidez regulatória** (uma estratégia só para todo contexto).

Identificado o padrão, a intervenção se encadeia: para **evitação**, exposição e aceitação; para **supressão**, expressão graduada e treino de consciência; para **falhas de reavaliação**, reestruturação cognitiva; e para **limitação na emoção positiva**, treino deliberado da experiência de prazer e recompensa.

Dois exemplos de aplicação

No **transtorno de ansiedade generalizada**, o foco recai sobre a interrupção do ciclo de preocupação. No **transtorno explosivo intermitente**, sobre a pausa e a **granularização** da emoção — ampliar o vocabulário afetivo para que “raiva” se diferencie em frustração, humilhação, sobrecarga (Kashdan,

Barrett & McKnight, 2015). Em ambos, a lógica é a mesma: substituir evitação ou impulsividade por estratégias funcionais de enfrentamento.

Regulação interpessoal e o risco da bengala

A regulação também acontece por sistemas sociais, ancorada na teoria do apego como fonte de segurança (Zaki & Williams, 2013). A correção é natural e desejável — mas a **dependência excessiva de figuras externas**, como alguém que acompanha o paciente em todas as atividades, funciona como bengala: impede o desenvolvimento da autonomia e bloqueia a extinção dos medos.

O FECHO

A aula terminou num contraste que vale guardar: o alvo é a **vitalidade e o enfrentamento da vida** — não a busca de uma felicidade dopaminérgica. Regular emoção não é sentir menos; é conseguir viver a vida que importa carregando o que ela exige.

Referências

1. Albuquerque, A. S., & Tróccoli, B. T. (2004). Desenvolvimento de uma escala de bem-estar subjetivo. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 20(2), 153–164.
2. Aldao, A. (2013). The future of emotion regulation research: Capturing context. *Perspectives on Psychological Science*, 8(2), 155–172.
3. Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 217–237.
4. Bonanno, G. A., & Burton, C. L. (2013). Regulatory flexibility: An individual differences perspective on coping and emotion regulation. *Perspectives on Psychological Science*, 8(6), 591–612.
5. Bryant, F. B., & Veroff, J. (2007). *Savoring: A new model of positive experience*. Lawrence Erlbaum.
6. Dalgalarrodo, P. (2019). *Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais* (3ª ed.). Artmed.
7. Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271–299.
8. Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26.
9. Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348–362.
10. Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment. *Clinical Psychology Review*, 82, 101908.
11. Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 64(6), 1152–1168.
12. Kashdan, T. B., Barrett, L. F., & McKnight, P. E. (2015). Unpacking emotion differentiation. *Current Directions in Psychological Science*, 24(1), 10–16.
13. Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. *Perspectives on Psychological Science*, 3(5), 400–424.
14. Seligman, M. E. P. (2011). *Flourish*. Free Press.
15. Zaki, J., & Williams, W. C. (2013). Interpersonal emotion regulation. *Emotion*, 13(5), 803–810.

NOTA DE MÉTODO

Os casos clínicos citados em aula estão desidentificados. As lembranças pessoais compartilhadas pelos participantes durante o exercício de memórias positivas foram deliberadamente omitidas: são material de participantes, não conteúdo de aula. A conversa que antecedeu a aula — carreira acadêmica, publicação e plataformas de avaliação — também ficou de fora por não integrar o tema. Corrigi artefatos de transcrição: *Dalgala Rondo* → **Dalgalarrondo**; *hipotivação* → **hipoativação**. A referência à escala de bem-estar subjetivo foi ancorada na versão brasileira de Albuquerque e Tróccoli (2004), que é a de uso corrente no país; a aula não especificou qual instrumento. As referências de regulação emocional, flexibilidade regulatória, evitação experiencial, *savoring* e granularidade emocional foram acrescentadas para dar respaldo formal a afirmações feitas em aula sem citação explícita. Nenhuma citação foi construída para preencher lacuna.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão — e salve o PDF para acompanhar.

Investiguei a situação com detalhe — o elo do ciclo que costuma passar batido.

Perguntei qual estratégia o paciente usa e em que ponto do ciclo ela age.

Avaliei a funcionalidade da estratégia no contexto dele, em vez de classificá-la como boa ou ruim.

Checei se o problema é rigidez de uso — uma estratégia só para todo contexto.

Nomeei o padrão do sistema: hiperativação, hipoativação, evitação experiencial ou rigidez regulatória.

Antes de propor reavaliação, verifiquei se a situação não é caso de mudança, e não de resignificação.

Trabalhei a experiência de emoções positivas como alvo clínico, não como sobremesa.

Verifiquei se algum apoio interpessoal está funcionando como bengala.

MINHAS ANOTAÇÕES — O QUE LEVO PARA A CLÍNICA

Para revisar — responda

Responda com suas palavras. O PDF guarda o que você escrever.

1. O que muda na conduta quando se assume que emoções são amorais e o julgamento recai sobre o comportamento?

2. Descreva os quatro elos do ciclo de geração emocional com uma situação de um paciente seu.

3. Por que nenhuma estratégia de regulação é boa ou ruim em si? Dê um exemplo de uma que funcionou num contexto e falhou em outro.

4. Qual o risco ético da reavaliação cognitiva usada sem critério?

5. Diferencie hiperativação, hipoativação, evitação experiencial e rigidez regulatória — e a intervenção correspondente a cada uma.

6. Como você trabalharia a granularização emocional com um paciente que só nomeia “raiva” e “nada”?

7. Que paciente seu teria dificuldade de acessar uma memória positiva? Que intervenção você proporia?